doi: 10.3969/j.issn.1672-4933.2025.06.023

语言治疗师职业角色探讨

Exploring the Professional Role of Language Therapists

张俊玲　廉菲菲　李爱华

ZHANG Jun-ling, LIAN Fei-fei, LI Ai-hua

【摘要】探讨语言治疗师的角色定位，帮助专业人员深入了解语言治疗师职业角色。语言治疗师职业角色包括临床言语-语言康复、健康促进、疾病预防、多学科合作、教学与带教、科研开发6个主题，其角色是多重的，应掌握各角色间的转换，更好地服务于语言障碍患者。

【关键词】语言治疗师；职业角色；语言-言语障碍；语言治疗

【中图分类号】G762　　【文献标识码】A　　【文章编号】1672-4933(2025)06-0659-04

【Abstract】 To provide a comprehensive review of the role positioning of language therapists through the collection of domestic and foreign literature, in order to help relevant medical professionals in China gain a deeper understanding of the professional role of language therapists. The professional roles of language therapists include six themes: the role of language therapists in clinical language speech rehabilitation, health promotion, disease prevention, multidisciplinary collaboration, teaching guidance, and research and development. The role of a language therapist is multifaceted, familiar with and adaptable to role transitions, and better serving those in need.

【Key words】Language therapist; Professional roles; Language speech disorder; Language therapy

语言治疗是通过对语言障碍进行特殊教育和培养，再现、纠正和预防语言障碍的教育过程[1]。语言治疗师是对言语-语言障碍、吞咽障碍、认知障碍，如失语症、构音障碍、语言发育迟缓、口吃、嗓音障碍、认知交流障碍、吞咽-进食障碍等进行康复评定与治疗的从业人员[2]。通过语言治疗技术帮助语言障碍人群恢复或改善言语-语言功能，使其重新获得沟通交流能力。在康复治疗过程中，语言治疗师扮演诸多角色，本文回顾并梳理了语言治疗师的角色，为语言治疗师的角色扮演提供学习途径，指明工作方向和思路。

1 语言治疗现状

1.1 语言治疗的适应人群

我国言语-语言障碍患者众多，多种疾病或残疾均能造成言语-语言障碍，如发展性、获得性和退变性神经肌肉疾病以及言语器官损伤均可导致言语-语言障碍[3]。儿童语言障碍是由各种原因导致的语言发育迟缓或发育性言语困难，包括后天获得性失语、由听力障碍引起的言语障碍或发声器官病变造成的言语障碍、神经或精神性因素导致的语言障碍，如脑瘫、孤独症、精神发育迟滞、焦虑抑郁等，以及吞咽障碍合并言语障碍。脑中风常见的后遗症包括失语症、运动性构音障碍；神经-肌肉系统病变造成的言语障碍，如渐冻症；阿尔茨海默症、帕金森等老年性疾病也会导致语言沟通交流障碍；喉部病变或术后造成的嗓音障碍；还有因社会环境因素引发的语言障碍。

1.2 国内外语言治疗现状

20世纪60年代，发达国家康复医学迅速发展，语言治疗学日益受到重视，美国、加拿大、澳大利亚、日本、韩国等相继开设了语言治疗专业，培养临床和研究人员[4]。在加拿大、日本等地，语言治疗的范围涵盖语言障碍患者的筛查、评估、诊断和治疗，还包括对口吃、嗓音障碍、吞咽障碍、进食障碍等评估和治疗。美国的语言治疗体系不仅解决本领域的问题，也提供融合教育、宣传、合作、预防等一体的综合服务[5]。

我国的语言治疗在20世纪80年代逐渐发展起来。早期从业人员多是从欧美等国家进修而归，创建语言治疗室。随着语言康复技术的革新和发展，我国逐渐由非本学科人员转变为高等教育康复治疗技术专业人员从事语言治疗工作。语言治疗的覆盖面涵盖综合医院康复医学科、专科康复医院、民营康复机构和特殊教育学校。我国的语言治疗领域仍处于发展阶段。

2 语言治疗师的角色范围

语言治疗师的技能包括治疗、教学、人际交往和管理

作者单位：济南医院（济南市康复医院）康复医学科　济南　250000

作者简介：张俊玲　本科　主管康复治疗师；研究方向：语言-言语障碍康复治疗

通讯作者：李爱华，E-mail：16603257@qq.com

中国知网　https://www.cnki.net

技能[6]。其可通过沟通管理提高言语-语言障碍人群的生活质量[7]。2013年，在《巴西职业分类(Brazilian classification of occupations，CBO)13》中描述语言治疗师在治疗、预防、保健和康复方面发挥重要作用。此外，还需参加预防方案、健康促进、研究开发、其他任务和科学活动组织[8]。特殊教育学校将语言治疗师的职业角色界定为交流者、语言方案的协调者、信息提供者、倾听者和技能开发者、诊断者和学习者[9]。2022年，《我国职业分类大典》正式将康复治疗师回归第二类医疗卫生技术人员，保持了康复的医疗属性，强调其在预防、治疗、康复完整周期中的重要作用[10]。从语言治疗发展史来看，语言治疗师不再倾向于彼此孤立地工作，而应积极、负责任地与语言治疗团队讨论言语和语言障碍的诊断和治疗方案[11]。语言治疗师的角色定位不仅局限于临床疾病的语言治疗，已延伸到健康促进、预防、人际沟通、团队合作等领域，并扮演不同的角色。

3 语言治疗师的职业角色分析

3.1 语言治疗师在临床言语-语言康复中的角色

我国本科教育开设听力与言语康复专业的有首都医科大学、滨州医学院、上海中医药大学等院校。滨州医学院听力与言语康复学专业课程设置了基础听力学、营养学与听力健康、诊断听力学等42门课程[12]。卓大宏[13]明确了语言治疗师的岗位任务，接诊言语-语言障碍患者需具备的专业技能，运用专业知识评估分析言语-语言障碍的临床特点、致病原因、障碍分型或分类、损伤水平或阶段、残存功能、意识状况、配合度、患者或家属期望达到的功能状态、预后影响因素、对预后做出初步判定、制订详细康复训练方案。训练过程中对突发情况的处理，如癫痫发作、血压过高或过低、血糖过低、头晕、心率增快、误咽导致的窒息、情绪易激怒、行为狂躁、儿童哭闹、家属不配合等。

语言治疗师是帮助语言交流障碍患者采取干预措施，使言语-语言、吞咽、认知功能得以改善[14]。较高的患者信任度可缓和医患双方态度，增强患者诊疗积极性，促进其遵医嘱配合治疗，接受和包容治疗过程中可能出现的不适[15]。扎实的理论基础知识是患者对治疗师产生信任的有力支撑，对患者的疑问和不解，治疗师应从专业角度做出解释或演示，才能顺利完成康复治疗。

3.2 语言治疗师在健康促进中的角色

3.2.1 语言治疗师在言语-语言障碍知识推广中的角色 语言治疗师不仅是言语-语言障碍康复的指导者和康复治疗处方的制订者，也是语言康复治疗知识的推广者，分享语言康复知识，鼓励患者养成自我康复的习惯，以维持在康复机构获得的语言技能。刘阳等[16]通过科室护士和曾患失语症者作为同伴，实施语言治疗，结果显示患者的语言功能、日常交流能力、生活质量明显提高。关于应用行为分析疗法联合家庭教育在孤独症谱系障碍患儿中的应用中，家长实施家庭干预，机构每月家长培训2次，每月第4周进行家访，指出训练缺陷，制订训练方案。结果显示家庭训练组和机构训练组相比无显著差异，提示仅在机构对患儿进行训练的作用有限，充分调动家庭教育资源十分必要[17]。语言治疗师与口吃者间的工作联盟很重要，包括对治疗目标的共同理解、关于治疗任务的协议以及二者之间的纽带等要素[18]。

3.2.2 语言治疗师在营养管理中的角色 营养不良、形体消瘦是吞咽障碍患者常见的不良后果，是需要解决的首要问题[19]。脑卒中后吞咽功能的改善主要是语言治疗师干预的结果。多学科专业人员共同干预，有助于确保营养摄入，改善营养状况。配合临床医护人员密切监测患者的营养状况，根据患者的吞咽功能状况、进食体位设定、营养风险筛查、每日进食种类、性状、餐数、需求量、进出量、进食禁忌、喜好等指导家属准备食物原材料、制作方法、经口进食的注意事项，以满足患者的营养需求[20,21]。误吸、呛咳引发的呼吸道感染会加剧吞咽障碍患者机体营养的消耗，使其营养状况恶化，从而影响康复[22]。语言治疗师指导照顾者制作吞咽障碍食品可有效降低患者误吸风险[19]。语言治疗师在有效改善患者营养状态、降低误吸风险方面是重要的参与者。

3.2.3 语言治疗师在心理管理中的角色 脑卒中是导致语言障碍的常见疾病，由于恢复周期长，患者日常生活自理能力、语言交流能力、吞咽功能等受限，易出现抑郁焦虑等情绪障碍，影响康复效果[23]。随着时间的延长会影响患者治疗依从性，进一步加重心理障碍，形成恶性循环[24]。语言治疗师在训练过程中通过口语、文字或身体语言了解患者的困扰，积极给予心理疏导，帮助其树立康复信心，对于患者的康复非常重要。王莉娜等[25]通过临床多中心研究，对语言障碍患者进行心理干预，明显改善其抑郁焦虑情绪，提升整体康复疗效。马洪卓[26]纳入67例失语症患者给予心理干预结合语言康复训练，总有效率(89.55%)显著高于常规语言康复训练(77.61%)。因此，康复治疗师对语言障碍患者的心理干预在临床疗效中是协同增效的。

语言治疗师的言行举止关系到家庭的稳定与和谐[27]。由于语言障碍患者交流能力、认知能力下降，对家属形成极强的依赖性。家属不仅需照顾患者衣食住行，还要面对其暴躁脾气，长期的心理压抑使家属心理崩溃。语言治疗师观察、关注家属的心理变化，询问、倾听其苦

中国知网 https://www.cnki.net

闷,从专业角度解释患者出现情绪障碍的原因,指导其掌握与患者的沟通技巧,缓解不良情绪。

3.3 语言治疗师在疾病预防中的角色

预防是经济有效的健康策略[28],预防疾病是保护人类健康的重要手段和措施。语言治疗师可针对预防干预和实施提供信息,为预防计划的制订提供依据[29]。对疾病的监督和指导是语言治疗师在疾病预防中担任的重要角色,如观察患者头颈部放松运动是否发生头晕,临床用药是否对患者的意识状况及语言-吞咽功能产生影响,吞咽功能障碍患者的营养和口腔卫生状况,口吃患者在社会交往中的言语流畅度,失语症患者是否将语言技巧运用到实际生活中,预防构音和吞咽器官的僵硬或萎缩[30],流涎带来的不良形象,吞咽障碍患者误吸的发生和营养不良[31],认知障碍患者的脑功能减退,用嗓不当引发的嗓音障碍等。语言治疗师通过扎实的专业知识帮助言语-语言功能障碍患者减少疾病发生,使其功能状态得以维持。

3.4 语言治疗师在多学科合作中的角色

在多学科治疗背景下,可实现无缝规划和更有效的结果,同时降低断章取义或以禁忌方式实施干预策略的可能性[32]。在新生儿或婴幼儿喂养障碍领域,语言治疗师可从其专业角度分析障碍原因,与临床医生共同制订康复训练计划。头颈部或口腔肿瘤放化疗或术后、帕金森病引发吞咽障碍[33,34],语言治疗师可为患者制订适宜的食物种类和性状。在康复护理延伸工作中,语言治疗师是优秀的指导者。面部运动不对称[35]、面部表情僵硬不柔和、粗厚的嗓音不动听,通过语言治疗师的康复,这类人群可以恢复较好的功能状态,带来了较高的社会效应。

3.5 语言治疗师在教学、带教中的角色

语言治疗师不仅要成为1名专业的治疗师,还担负着教学和带教任务。目前,国内多家医学院校的康复治疗技术专业设置了言语治疗学,选择高年资语言治疗师作为教学老师,从根本上保障师资队伍的高标准、高质量[36]。语言治疗师将大量临床治疗案例在授课中传授,使课堂不再乏味、空洞,从而提高听课效率和兴趣,增强了学生对理论知识的理解。

临床实习是医学教育过程中的关键环节,不仅是学生将理论知识与实践相结合的重要途径,也是全面提高学生综合素质、培养学生解决实际问题能力及创新精神的必经过程[37]。语言治疗师在临床带教中,带领学生将理论知识灵活运用到临床及解决特殊问题中。与初诊患者的医患关系建立、资料收集、言语-语言障碍功能评估、康复目标和训练计划制订、训练注意事项、每日患者治疗总结等,语言治疗师以身作则,亲自示范,直至学生能够独立进行康复治疗。

3.6 语言治疗师在科研中的角色

语言治疗师承担临床科研任务,在临床治疗中采取干预手段对解决某种问题有显著效果,可将其做成随机试验研究。大量临床案例使得语言治疗师不断将现有技术进行改良、革新或开发,目的是显著提高治疗效果。大量优秀康复治疗文献由治疗师作为第一作者书写[38,39]。

4 总结

关于语言治疗师的职业角色研究大多为从业现状、受教育程度、工作满意度等。目前国内外均没有对语言治疗师职业角色的深入探讨,大众对语言治疗师角色的理解和研究不够深入。本文通过对语言治疗师多重角色的阐述,帮助大众对语言治疗师有正确的认识,以便为解决语言障碍问题指导方向和思路。希望在未来的康复治疗工作中,语言治疗师能够真正担负起以上角色赋予的责任,做好健康的守护者。

参考文献

[1] Ilkhamovna RM. Mechanisms for developing reflexive skills in future speech therapists[J]. Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research,2024,11(11):302-306.

[2] 陈卓明.语言治疗学.第3版[M].北京:人民卫生出版社,2018.34-35.

[3] 单春雷.抓住大好机遇,实现中国言语治疗新跨越[J].中国康复,2016,31(6):403-404.

[4] 李胜利.促进国内言语治疗发展,尽快与国际接轨[J].中国康复,2014,29(5):323-324.

[5] 陈雯珺,朱双双,钱倩.发达国家语言康复行业发展现状[C].国家语言文字工作委员会.语言生活皮书——世界语言生活状况报告(2019).2019.161-166.

[6] Davies P, Van der Gaag A. The professional competence of speech therapists. III: Skills and skill mix possibilities[J]. Clinical rehabilitation, 1992, 6(4): 311-323.

[7] O'Reilly AC, Walshe M. Perspectives on the role of the speech and language therapist in palliative care: An international survey[J]. Palliative Medicine, 2015, 29(8): 756-761.

[8] Da Silva BGM, Nascimento CL, Nakamura HY. Occupational Health: what is the role of the speech therapist?[J]. Revista CEFAC, 2020, 22(6): e12821-1-e12821-8.

[9] Haynes C. The role of the speech therapist in a language school[J]. Child Language Teaching and Therapy, 1985, 1(2): 172-181.

[10] 曹泳敏,陈泖泽,李勇成,等.基于康复治疗师分类调整的在校生的心理和就业规划变动研究[J].社会科学前沿,2023,12(3):1261-1268.

[11] Davies P, Van der Gaag A. The professional competence of speech therapists. I: introduction and methodology[J]. Clinical rehabilitation, 1992, 6(3): 209-214.

[12] 唐柳青.中英"言语康复学"专业本科教育设置比较研究[D].天津理工大学,2018.

中国知网 https://www.cnki.net

[13] 卓大宏,戴红.我国康复治疗技术岗位任务分析的研究[J].中国康复医学杂志,2004,6:11-12.

[14] Barbara C,Susan RJ,邹艳辉.«现代护理学»之当代护士的职责和职业机会(中)[J].当代护士(综合版),2013,20(9):23-24,27.

[15] Thorn DH, Bloch DA, Segal ES. An intervention to increase patients' trust in their physicians. Stanford Trust Study Physician Group[J]. Academic Medicine,1999,74(2):195-198.

[16] 刘阳,刘萧,顾晓凤.同伴教育在老年失语症患者中的应用[J].中国听力语言康复科学杂志,2023,21(3):310-313.

[17] 成诺,严芳.应用行为分析疗法联合家庭教育训练在孤独症谱系障碍患儿中的应用[J].护理研究,2021,35(22): 4084-4088.

[18] Sønsterud H, Kirmess M, Howells K, et al. The working alliance in stuttering treatment: a neglected variable?[J]. International journal of language & communication disorders, 2019, 54(4):606-619.

[19] 中国吞咽障碍康复评估与治疗专家共识组.中国吞咽障碍评估与治疗专家共识(2017年版)[J].中华物理医学与康复杂志,2018,40(1):1-10.

[20] 蒋欢,赵中,李建平,等.基于NRS 2002评分的营养管理模式对脑梗死吞咽障碍患者营养状况的影响[J].中国食物与营养,2024,30(2):76-80.

[21] 刘春燕,刘婷,黄慧.基于营养风险等级的多学科营养管理模式在脑梗死吞咽障碍患者中的应用研究[J].中国当代医药,2023,30(25):60-64.

[22] 张丽芳,何小俊.基于多学科协作的项目管理法在高龄吞咽障碍病人营养管理中的应用[J].实用老年医学,2023,37(11):1185-1188.

[23] 苏曼莉,李艳芳.早期心理护理对脑卒中后抑郁患者神经心理的影响[J].现代中西医结合杂志,2015,24(23):2602-2603.

[24] 于霞.综合心理护理对脑卒中后抑郁患者心理状态及希望 水平的影响[J].实用临床医药杂志,2016,4(2):31-33.

[25] 王莉娜,董文敏,王海帆,等.针灸及心理干预配合语言康复训练治疗脑卒中后语言障碍伴抑郁焦虑的临床效果分析[J].心理月刊,2021,16(3):78-79.

[26] 马洪卓.心理结合语言康复在脑卒中后语言及心理障碍病人中的应用研究[J].中西医结合心脑血管病杂志,2016,14(11):1279-1281.

[27] 李艳,张长杰,王晶.浅谈康复治疗师在医疗服务中的语言艺术[J].中国康复理论与实践,2008,14(10):999-1000.

[28] 李光琳,李程跃,胡志,等.疾病预防控制:保护人类健康最经济有效的基础之策[J].中国农村卫生事业管理,2023,43(11):762-769.

[29] Nation M, Crusto C, Wandersman A, et al. What works in prevention: Principles of effective prevention programs[J]. American psychologist, 2003, 58(6-7): 449-449.

[30] 侯坤华,李芊芊,彭燕秋,等.预防性吞咽训练在头颈部肿瘤放化疗患者的应用进展[J].护理学报,2021,28(13):24-28.

[31] 张丽芳,卢青英,吴小平.间歇经口管饲联合康复训练在脑卒中吞咽障碍中的应用及对营养状况的影响[J].中外医疗,2020,39(36):133-136.

[32] LaFrance DL, Weiss MJ, Kazemi E, et al. Multidisciplinary teaming: Enhancing collaboration through increased understanding[J]. Behavior analysis in practice, 2019, 12(3): 709-726.

[33] 李芳莲,何春娇,蒋颖,等.多学科合作护理模式在头颈部肿瘤患者中的应用进展[J].微创医学,2023,18(4):506-509.

[34] 毛淼淼,段立晖.多学科合作吞咽模式干预对帕金森病吞咽障碍患者吞咽功能及误吸率的影响[J].中国实用神经疾病杂志,2024,27(2):230-235.

[35] 邵雅楠.表情肌康复训练联合常规针刺对恢复期周围性面瘫患者神经功能改善作用的观察[J].中国康复,2019,34(9):477-479.

[36] 叶淼,梁一雄,黄秋晨,等.基于康复胜任力架构对北京市康复治疗师规范化培训效果的分析[J].中国康复理论与实践,2023,29(10):1233-1240.

[37] 蔡海鸥.康复医学教学模式探讨[J].中国康复医学杂志,2011,15(5):306-306.

[38] 郑亚星,吴亚岑,杨宇祥,等.咽腔电刺激在吞咽障碍康复治疗中的研究进展[J].中国康复,2022,37(11):684-687.

[39] 甘莉,杨馨,李利娟,等.朗读治疗法同步远程言语康复对脑卒中后失语症患者语言能力和生活质量的影响[J].中华物理复医学与康复杂志,2023,45(3):199-204.

收稿日期 2024-01-04
责任编辑 薛　静

中国知网 https://www.cnki.net